

PHARMACOLOGIE DES MIGRAINES

TTT DE CRISE

Evaluation de l'efficacité des ttt non spécifiques après 2h : **Si soulagement** -> pas de changement | **Sinon** : AINS de suite et triptans si pas de changement après 2h | **Si aucune réponse aux triptans** : dérivés ergotés.

On évite caféine, paracétamol et opioïdes : risque **d'abus** +++

Pas de médicaments efficaces sur l'aura mais amélioration des signes associés

→ **Céphalées chroniques si abus de mdt**

Spécifique : vasodilatation des artères méningées

Variabilité de la réponse aux mdt :

- Liée à la crise : tb dig type nausées et vmt qui peuvent modifier les cinétiques, prise tardive, présence ou non d'aura (attendre le début de la céphalée pour la prise), prise trop importante de mdt
- Liée au mdt : forme pharmaceutique, biodispo, t1/2

Triptans = agoniste 5HT1B/D, **SC, VO, Pulv° nasale** (bonne dispo SC, pas VO)

- Vasoconstriction des artères anormalement dilatées
- Inhibition activation système trigémino-vasculaire
- inhibition transmission du msg nociceptif trigéminal
- Diminue l'intensité des tb et l'incapacité fonctionnelle

!! R présent au niveau coronaire : risque d'ischémie myocardique

Mauvaise absorpt° oral pour **sumatriptan** | Absorption lente pour **naratriptan** et **almotriptan** | **Zolmitriptan** | **Naratriptan**

Elimination rapide, durée d'action courte

Nouveau triptans : + rapide, + lipophile, action + longue

EI : dose dpdt, f° de la forme, mineurs, vasoconstriction et spasmes coronariens, oppression, chaleur, signes sérotoninergiques (tb dig), somnolence...

IM : **IMAO, ISRS, dérivés ergotés** → syndrome 5HT

CI : pb <3-vasc (bilan), ttt avec ergot et 5HT, patient avec céphalées non migraineuses

Dérivés ergotés : agonistes partiels sur les R alpha-adrénergiques et 5HT1B/D, **Pulv° nasale** (Résorption mauvaise PO)

Tartrate d'ergotamine : pas en continu, **VO** | **Dihydroergotamine**

- Vasoconstriction des artères extra-crâniennes (5HT), artères périph (NA)
- Veinoconstriction
- Fermeture shunt artérioveineux
- Action émétisante

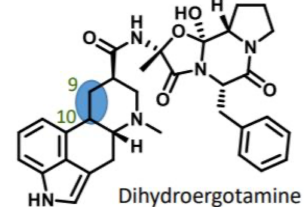
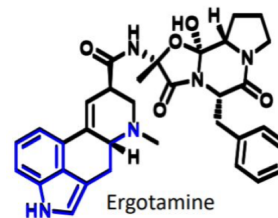
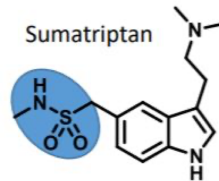
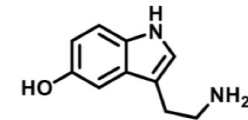
→ Stase gastrique + 1er passage hépatique = faible biodispo et variabilité

→ Association caféine pour augmenter la biodispo

T1/2 long : !! accumulation → pas pour les patients si + d'1 crise/sem

Métabolisation par les **CYP3A4**

EI : tb dig + <3-vasc dus aux R alpha-adré



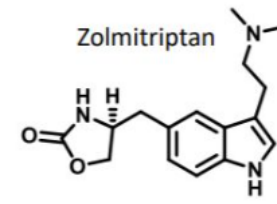
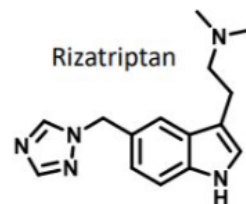
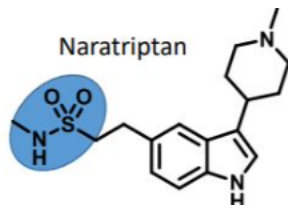
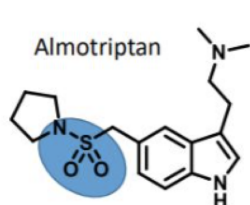
Non spécifique : symptômes

Antalgiques (paracétamol, amidopyrine, dérivés pyrazolés) et **AINS** :

- lutte contre la douleur et RI
- Automédication +++ ⇒ !! aux céphalées chroniques

AINS (naproxène, indométacine) : inhibe la COX

Acide acétylsalicylique +/- métoclopramide qui augmente la mobilité intestinale car diminution de la résorption pdt la crise



TTT DE FOND : 2 à 5 crises violentes / mois & abus antalgiques ou dérivés d'ergot

Choix du méd. dpd des ttt antérieurs, sévérités des crises, CI, EI et facteurs aggravants (stress : B-bloq / anxiété et dépress° : amitriptyline)

→ **Efficacité** visible en 2-3 mois : efficace si diminution des crises de 50%, moins sévères et moins longues

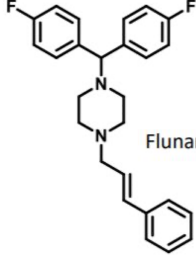
→ Prise ttt pdt **4-6 mois** si efficace, commence par **monothérapie de faible dose**, augmentation et **diminution progressive**

→ **Si récidive après 6-12 mois** : reprendre le même ttt de fond

→ Pas d'asso de 2 ttt de fond / Pas de meilleur mdt par rapport à un autre

1ère intention : B-bloquant, oxétorone, amitriptyline | **2ème intention** : pizotifène, flunarizine, valproate de sodium, gabapentine

! El généraux : **Prise de poids** (anti-5HT, flunarizine, valproate de sodium) et **Sédation** (anti-5HT, flunarizine, anti-épileptiques)

Antagonistes R 5HT2	Sympatholytiques : B-bloq	Inhib. Calciques	Antidep./Antiépilept.	Dérivés ergotés
<u>Méthysergide</u> : pour les migraineux résistants aux autres ttt : 1 mois de ttt tous les 6 mois (poso progressive par tatonnement) - Inhibition vasoconstriction - Inhibition agrégation plaquettaire - Agoniste partiel R 5HT du tronc cérébral <i>El : tb dig, malaise, effet anti-H1 (sommolence), fibrose péritonéale</i> <u>Pizotifène</u> : <i>El : anti-H1, constipation, prise de poids</i> <u>Oxétorone</u> : <i>El : anti-H1</i> PK : <u>oxétorone</u> et <u>pizotifène</u> : T1/2 long donc 1 prise/j	<u>Propranolol</u> : 80-160 mg/j en 2 prises <u>Métoprolol</u> Mdt de ref, pas d'activité sympathomimétique intrinsèq. - Maintien du tonus vasoconstricteur - Bloque la synthèse du thromboxane A2 3-4 mois de ttt <i>El : limitat° à l'effort, baisse FC, peut aggraver les migraines avec aura</i>	<u>Flunarizine</u> : si échec des autres ttt pour < 6 mois PK : T1/2 long donc EI +++  Flunarizine <u>Vérapamil</u> : uniquement AVF - Anticalciques - Antihistaminique - Antisérotoninergique - Antidopaminergique <i>El : somnolence, prise de poids, synd. parkinsonien, dyskinésie tardive, dépress°</i>	Antidépresseurs tricycliq : <u>amitriptyline</u>, <u>clomipramide</u> Antiépileptiques : <u>Topiramate</u>, <u>valproate de sodium</u>, <u>gabapentine</u> (pas d'AMM pour les 3)	<u>Dihydroergotamine</u> Agoniste partiel 5HT + alpha <i>El : rapport bénéfice/risque</i>

